ACC/AHA vydali prvé odporúčanie pre kardiovaskulárno-renálno-metabolický syndróm

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 11.06.2026



Ilustračná scéna. Prvé spoločné odporúčanie uzatvára kruh, ktorý sa doteraz hodnotil po častiach.

Americká kardiologická spoločnosť a Americká asociácia srdca vydali prvé spoločné odporúčanie zamerané na **kardiovaskulárno-renálno-metabolický syndróm**, označovaný ako **CKM syndróm**. Ide o nový koncepčný rámec, ktorý prepája obezitu, metabolické poruchy, chronickú chorobu obličiek a kardiovaskulárne ochorenia do jedného kontinuálneho modelu rizika a starostlivosti.

Odporúčanie vzniklo v spolupráci viacerých odborných spoločností vrátane American Diabetes Association, Obesity Association a American Society of Nephrology. Nahrádza staršie odporúčanie AHA/ACC z roku 2013 pre manažment nadváhy a obezity u dospelých.

Obezita ako centrálny faktor multiorgánového poškodenia

Nové odporúčanie posúva pohľad na obezitu: už nie je iba jedným z rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení, ale **ústredný patofyziologický motor multiorgánovej progresie**.

Autori zdôrazňujú, že nadbytočné a dysfunkčné tukové tkanivo vedie k rozvoju metabolických rizikových faktorov, chronickej choroby obličiek, subklinického kardiovaskulárneho poškodenia a napokon ku klinicky manifestnému kardiovaskulárnemu ochoreniu. Cieľom je preto zachytiť pacientov skôr, ešte pred vznikom ireverzibilných orgánových následkov.

Štádiá CKM syndrómu

Odporúčanie zavádza štvorstupňový model CKM syndrómu.

Štádium 1 zahŕňa pacientov s nadváhou, obezitou alebo prediabetom bez ďalších metabolických rizikových faktorov, ochorenia obličiek alebo kardiovaskulárneho ochorenia.

Štádium 2 zahŕňa prítomnosť aspoň jedného metabolického rizikového faktora, napríklad hypertenzie, hypertriglyceridémie, diabetu 2. typu alebo metabolického syndrómu, prípadne stredne až vysoko rizikovej chronickej choroby obličiek, ale bez zjavného kardiovaskulárneho ochorenia.

Štádium 3 zahŕňa subklinické kardiovaskulárne ochorenie spolu s rizikovými faktormi CKM, 10-ročné kardiovaskulárne riziko podľa PREVENT-CVD najmenej 20 %, alebo veľmi vysoké riziko ochorenia obličiek podľa kritérií KDIGO.

Štádium 4 zahŕňa už diagnostikované kardiovaskulárne ochorenie, napríklad ischemickú chorobu srdca, srdcové zlyhávanie, cievnu mozgovú príhodu, periférne artériové ochorenie alebo fibriláciu predsiení, spolu s nadváhou, obezitou, metabolickými rizikovými faktormi alebo ochorením obličiek.

Liečba: od životného štýlu po GLP-1 a inhibítory SGLT2

Manažment má byť odstupňovaný podľa štádia ochorenia. V skorších štádiách sa kladie dôraz na intenzívnu úpravu životného štýlu, redukciu hmotnosti, farmakoterapiu obezity a u vybraných pacientov aj na metabolickú a bariatrickú chirurgiu.

Novinkou je, že odporúčanie po prvý raz zahŕňa **agonisty GLP-1 receptorov** pre vybraných pacientov s obezitou, diabetom 2. typu a ďalšími kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi s cieľom znížiť riziko kardiálnych príhod.

U pacientov s diabetom 2. typu a CKM syndrómom v štádiu 2 alebo 3 sa ako prah pre začatie liečby GLP-1 terapiou, inhibítormi SGLT2 alebo ich kombináciou uvádza 10-ročné riziko PREVENT-CVD najmenej 7,5 %.

Potreba koordinovanej starostlivosti

Odporúčanie odmieta izolovaný, odborovo rozdrobený prístup. Pacienti s CKM syndrómom často prechádzajú medzi diabetológom, nefrológom, kardiológom, obezitológom a všeobecným lekárom, čo môže viesť k nejednotnej a oneskorenej liečbe.

Odporúčanie preto zdôrazňuje potrebu interdisciplinárnych modelov starostlivosti a určenia koordinátora, ktorý bude sledovať riziko, implementáciu odporúčanej liečby a kontinuitu starostlivosti.

Autori sprievodného editoriálu však upozorňujú, že implementácia nebude jednoduchá. Mnohé zdravotné systémy nemajú dostatočnú infraštruktúru na integrovanú CKM starostlivosť, prístup k liekom proti obezite je nerovnomerný a úhradové mechanizmy často podporujú skôr epizodickú než dlhodobú preventívnu starostlivosť.

Praktický význam

Hlavný prínos dokumentu nie je v jednotlivých terapeutických krokoch, ale v zmene myslenia. Kardiovaskulárne, metabolické a renálne riziko sa nemá posudzovať oddelene. CKM syndróm je jeden prepojený klinický proces, ktorý sa často začína už nadváhou, obezitou alebo prediabetom a môže končiť závažným kardiovaskulárnym ochorením a predčasnou mortalitou.

Pre klinickú prax to znamená potrebu skoršej identifikácie rizikových pacientov, dôslednejšej liečby obezity, aktívneho manažmentu diabetu a chronickej choroby obličiek a lepšej koordinácie medzi odbornosťami.

Zdroj: *Medscape, ACC/AHA Release First-Ever Guideline on CKM Syndrome (2026). Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=acc-aha-ckm-syndrom-prve-odporucanie · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.